

TEMA 9.58 • RESPIRATORIO

Disfonías Crónicas

PERFIL EUNACOM 1.09.58

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a los Diagnósticos Diferenciales de la Difonía Aguda

En el enfrentamiento de un paciente con estridor y dificultad respiratoria, es fundamental distinguir la **Laringitis Obstructiva** viral de otras entidades que pueden simularla o presentar una gravedad significativamente mayor. Los dos principales diferenciales son el **Crup Espasmódico** y la **Epiglotitis Aguda**.

1. Crup Espasmódico (Laringitis Estridulosa)

El crup espasmódico es una entidad benigna que se presenta de forma muy similar a la laringitis obstructiva, pero con características evolutivas propias.

Clínica y Presentación

- **Inicio y fin súbito:** Los síntomas aparecen de forma brusca y suelen durar solo unos minutos antes de mejorar espontáneamente.
- **Predominio nocturno:** Es clásico que el niño se despierte en la noche con una obstrucción importante.
- **Recurrencia:** Puede ocurrir en una sola noche o repetirse durante 1 a 4 noches seguidas.
- **Ausencia de fiebre:** A diferencia del crup viral, habitualmente no hay fiebre, aunque puede haber síntomas leves de infección respiratoria alta previa.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: No está del todo clara, pero se asocia a una hiperreactividad laríngea. Los desencadenantes pueden ser virales (distintos a Parainfluenza), alérgicos, irritación por reflujo gastroesofágico o incluso la aspiración de pequeñas partículas de comida que generan un espasmo laríngeo reflejo.

Diagnóstico y Manejo

El diagnóstico es estrictamente **clínico**. Dado que es un cuadro autolimitado y benigno, el manejo principal es: 1. **Educación a los padres:** Explicar la naturaleza benigna del cuadro. 2. **Aire húmedo:** Tradicionalmente se recomienda para calmar el espasmo. 3.

Observación: En la mayoría de los casos no requiere fármacos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si el paciente llega a la urgencia con una obstrucción severa o si existe duda diagnóstica con una **Laringitis Obstructiva** viral, se puede tratar con **Adrenalina racémica** y **Dexametasona** (0.6 mg/kg) mientras se observa la evolución.

2. Epiglotitis Aguda

La epiglotitis es una infección bacteriana grave de la epiglotis y las estructuras supraglóticas. Es una **emergencia médica** que amenaza la vida debido al riesgo de obstrucción completa de la vía aérea.

Etiología

Históricamente, el principal agente era *Haemophilus influenzae* tipo B (HiB). Gracias a la vacunación masiva, su incidencia en niños ha disminuido drásticamente, desplazándose el perfil epidemiológico hacia adultos y otros patógenos: - *Streptococcus* spp. - *Staphylococcus aureus*. - *Haemophilus influenzae* no tipificables.

Cuadro Clínico

Se caracteriza por una progresión rápida (horas) de los siguientes síntomas: - **Odinofagia severa y Sialorrea:** El dolor es tan intenso que el paciente no puede tragar su propia saliva (babeo). - **Voz de "papa caliente":** La resonancia de la voz cambia debido al gran edema de la epiglotis. - **Posición de tripode:** El paciente se inclina

hacia adelante, apoyando las manos y estirando el cuello para maximizar la apertura de la vía aérea. - **Aspecto tóxico:** Fiebre alta y compromiso del estado general (sugere de **Sepsis y Shock Séptico**). - **Estridor:** Aparece de forma tardía en comparación con la laringitis.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Peligro! Ante la sospecha de epiglotitis, **NO se debe examinar la faringe con un depresor de lengua** si no se cuenta con equipo de intubación inmediata, ya que esto puede desencadenar un espasmo laríngeo y obstrucción total.

Diagnóstico

1. **Clínico:** Alta sospecha ante la tríada de babeo, estridor y posición de tripode.
2. **Visualización directa:** Mediante laringoscopia (directa o indirecta con espejo) realizada por un especialista. Se observa una epiglotis "rojo cereza" y edematosa.
3. **Radiografía lateral de cuello:** Se observa el **Signo del Pulgar** (una epiglotis engrosada que parece la silueta de un pulgar).

Manejo y Tratamiento

El manejo debe ser intrahospitalario y multidisciplinario (Pediatría/Medicina Interna, Otorrinolaringología, Anestesia).

- **Asegurar la Vía Aérea:** Es la prioridad absoluta. Debe realizarlo el personal más experimentado (especialista) debido a que se considera una **vía aérea difícil**.
- **Antibioticoterapia Empírica:**
 - **Ceftriaxona** (Elección para *H. influenzae*).
 - En adultos o ante sospecha de *S. aureus*, añadir **Cloxacilina** o **Cefazolina**.
 - Si se sospecha SAMR (*Staphylococcus aureus* resistente a meticilina), considerar **Vancomicina**.
- **Corticoides y Adrenalina:** Pueden ayudar a reducir el edema en la fase aguda, aunque no sustituyen el manejo de la vía aérea ni los antibióticos.

Resumen Comparativo: Laringitis vs. Epiglotitis vs. Crup Espasmódico

TABLA 9.58.1: CARACTERÍSTICA VS CRUP VIRAL (LARINGITIS OBSTRUCTIVA)			
CARACTERÍSTICA	CRUP VIRAL (LARINGITIS OBSTRUCTIVA)	CRUP ESPASMÓDICO	EPIGLOTITIS AGUDA
Etiología	Viral (Parainfluenza)	Alergia / Reflujo / Viral	Bacteriana (HiB, Strep, Staph)
Inicio	Pródromo catarral (días)	Súbito (nocturno)	Rápido (horas)
Fiebre	Moderada	Ausente	Alta / Aspecto Tóxico
Babeo (Sialorrea)	Ausente	Ausente	Presente
Tos	"Perruna" (Metálica)	"Perruna"	Escasa o ausente
Voz	Disfonía	Disfonía	Voz de "papa caliente"
RX Cuello	Signo de la punta de lápiz	Normal	Signo del Pulgar
Tratamiento	Corticoides / Adrenalina	Observación / Humedad	Vía aérea + Antibióticos

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si el caso clínico describe a un niño con fiebre alta, que no puede tragar (sialorrea) y está en posición de trípode, marca siempre **Epiglotitis** y prioriza el **manejo de la vía aérea**. Si el cuadro es nocturno, súbito y cede solo, piensa en **Crup Espasmódico**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una profesora de 38 años consulta por disfonía de 2 meses de evolución que empeora durante la jornada laboral pero persiste parcialmente en reposo. No fuma ni presenta reflujo. Se realiza nasofibrolaringoscopia que muestra lesiones bilaterales simétricas en el tercio medio de ambas cuerdas vocales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento indicado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Disfonías Crónicas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Disfonía crónica: dura más de 3 semanas; estudio siempre con nasofibrolaringoscopia
- Nódulos vocales: bilaterales, abuso vocal, manejo funcional (reposo vocal y técnica de fonación)
- Disfonía musculotensional: nasofibrolaringoscopia normal, mejora con reposo, misma terapia funcional
- Polipos vocales: unilaterales, asociados a tabaco/reflujo/trauma vocal agudo, manejo quirúrgico
- Edema de Reinke (corditis polipoidea): asociado a tabaco/reflujo/hipotiroidismo, manejo de la causa más reposo vocal
- Parálisis del nervio laríngeo recurrente: voz bitonal de bajo volumen, causada por cirugía o cáncer de cuello/tórax
- La electromiografía del laríngeo recurrente define el pronóstico (neuroparálisis vs. sección del nervio)
- Cáncer de laringe: antecedente de cigarrillo, diagnóstico definitivo con biopsia por laringoscopia directa
- La parálisis bilateral del laríngeo recurrente puede causar disnea grave con pérdida de vía aérea

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DISFONIAS CRONICAS)**PREGUNTA 1**

Una profesora de 38 años consulta por disfonía de 2 meses de evolución que empeora durante la jornada laboral pero persiste parcialmente en reposo. No fuma ni presenta reflujo. Se realiza nasofibrolaringoscopia que muestra lesiones bilaterales simétricas en el tercio medio de ambas cuerdas vocales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento indicado?

- A) Polipos vocales; cirugía para extirpación y biopsia
- B) Nódulos vocales; reposo vocal y técnica de fonación adecuada
- C) Edema de Reinke; microcirugía laríngea
- D) Cáncer de laringe; laringoscopia directa para biopsia
- E) Disfonía musculotensional; reposo vocal únicamente

PREGUNTA 2

Un paciente de 55 años, fumador de 30 paquetes-año, consulta por disfonía progresiva de 6 semanas. La nasofibrolaringoscopia muestra una lesión unilateral exofítica en la cuerda vocal izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Indicar reposo vocal y técnica de fonación durante 3 meses
- B) Iniciar corticoides inhalados y control en 4 semanas
- C) Realizar laringoscopia directa para toma de biopsia de la lesión
- D) Iniciar tratamiento antireflujo empírico y reevaluar en 6 semanas
- E) Solicitar TAC de cuello y tórax sin necesidad de biopsia

PREGUNTA 3

Una mujer de 45 años presenta disfonía súbita asociada a dolor torácico intenso de inicio brusco, de tipo desgarrante, irradiado a la espalda. ¿Cuál es el diagnóstico que debe sospecharse en primer lugar?

- A) Infarto agudo al miocardio con parálisis del laringeo recurrente
- B) Cáncer de pulmón con invasión del nervio laringeo recurrente
- C) Disección aórtica con compresión del nervio laringeo recurrente
- D) Tromboembolismo pulmonar masivo
- E) Estenosis mitral con compresión del nervio laringeo recurrente

RESUMEN: DISFONIAS CRONICAS

Esta clase aborda el enfrentamiento de la disfonía crónica, definida como aquella que dura más de tres semanas. El estudio siempre se realiza con nasofibrolaringoscopia para visualizar la laringe e identificar la causa, y luego se realiza el tratamiento específico según el hallazgo. Las principales causas son: nódulos vocales (bilaterales, asociados a abuso vocal, manejo funcional con reposo y técnica de fonación), disfonía musculotensional (nasofibrolaringoscopia normal, mejora con reposo, mismo tratamiento funcional), polipos vocales (unilaterales, asociados a tabaco/reflujo/trauma vocal agudo, tratamiento quirúrgico), edema de Reinke o corditis polipoidea (edema de cuerdas vocales, asociado a tabaco/reflujo/hipotiroidismo, manejo con reposo vocal y tratamiento de la causa de base, eventualmente microcirugía), parálisis del nervio laringeo recurrente (voz bitonal de bajo volumen, causada por cirugía o cáncer de cuello/tórax, pronóstico con electromiografía) y cáncer de laringe (antecedente de cigarrillo, biopsia por laringoscopia directa, TAC para estadificación). Es fundamental diferenciar nódulos de polipos: los nódulos son bilaterales y de manejo funcional, mientras que los polipos son unilaterales y de manejo quirúrgico. La parálisis del laringeo recurrente tiene causas que van desde cirugía de tiroides hasta disección aórtica o estenosis mitral, lo que obliga a pensar en la anatomía del nervio para orientar el diagnóstico etiológico.